

Procedure og praktisk gennemførelse af projekt Digital årskontrol

Tak for jeres deltagelse.

Nedenfor beskrives trin-for-trin udvælgelse og rekruttering af deltagere samt proceduren for den digitale årskontrol.

Hvis I ikke allerede har udvalgt en projektansvarlig, er det tid til at gøre det. Den projektansvarlige står for kommunikationen mellem almen praksis og Steno Diabetes Center Aarhus, og er ansvarlig for at proceduren og tidsplaner for forsøget følges.

Udvælgelse af potentielle deltagere

Potentielle deltagere identificeres via patientlisten i forløbsoverblikket i KiAP (tilgængeligt via statistikmodul i lægesystemet eller via KiAP.dk). Den primære udvælgelse kan eventuelt delegeres til klinikens personale, da alle kriterier fremgår af patientlisten i forløbsoverblikket.

Trin 1.

For at deltage skal følgende parakliniske inklusionskriterier være opfyldt:

- Type 2-diabetes og følges i almen praksis
- eGFR >59 ml/min/1,73 m²
- HbA1c
 - <48 mmol/mol eller
 - 48–53 mmol/mol hvis det individuelle HbA1c-mål er <53 mmol/mol
- Urin albumin-kreatinin ratio (UACR)
 - <30 mg/g, eller
 - 30–300 mg/g og i behandling med organbeskyttende medicin: SGLT2-i eller GLP-1-agonist OG RAS-blokade med ACE-hæmmer eller ARB
- LDL <2,6 mmol/L

Personer som opfylder de parakliniske kriterier, registreres på ”deltagerlisten” (bilag 1).

Trin 2.

Listen gennemgås herefter individuelt af den behandlingsansvarlige behandler. I nogle klinikker kan dette med fordel fordeles, så hver behandler vurderer egne patienter, i andre klinikker vil sygeplejersken være den, som kender og følger de fleste patienter, og dermed bedst kan gennemgå listen.

Der skal foretages en individuel vurdering af, om der er forhold, som gør personen uegnet til et digitalt forløb. Det kan fx være alvorlig komorbiditet, manglende evne til at

opfylde de digitale krav (fx måling af hjemmeblodtryk), problemer med kommunikationen (herunder i Min Læge-appen) eller utilstrækkelige danskundskaber.

Det er en forudsætning for deltagelse, at personen kan læse og forstå dansk og modtage og sende beskeder i lægesystemet/"Min Læge" appen.

Gravide kan ikke deltage.

Når det er vurderet, om den enkelte person er egnet eller uegnet, noteres dette på deltagerlisten.

Trin 3.

Potentielle deltagere, som både opfylder de parakliniske kriterier, og hvor den ansvarlige diabetesbehandler finder det forsvarligt, at personen deltager i forsøget, sendes nu en kort besked (bilag 3) i lægesystemets beskedmodul, som modtages i Min Læge-appen. Beskeden indeholder følgende information:

1. At der er tale om en forespørgsel om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som undersøger, om personer med velbehandlet type 2-diabetes kan følges digitalt hvert andet år.
2. Link til skriftlig information om projektet (bilag 5).
3. Information om, at hvis den potentielle deltager ønsker yderligere information om forsøget, så bedes den potentielle deltager kontakte klinikken, og aftale tidspunkt for mundtlig information. hvor samtalen kan foregå uforstyrret, med tilstrækkelig tid til rådighed, og med eventuelt bisidder på medhør.
4. At hvis personen ikke ønsker deltagelse i projektet, kan personen besvare beskeden med "nej tak".

Trin 4.

På det aftale tidspunkt kontaktes den potentielle deltager telefonisk og gives mundtlig information om forsøget (se særskilt instruks, bilag 5). Efter den mundtlige information er givet, tilsendes den potentielle deltager en besked med link til skriftlig deltagerinformation og samtykke. (bilag 4).

Den potentielle deltager kan på ethvert tidspunkt afvise yderligere information eller deltagelse. I disse tilfælde er det vigtigt, at det registreres på Deltagerlisten, med kryds i feltet "afviser", så personer, som ikke ønsker at deltage, ikke kontaktes igen.

Trin 5.

Når deltageren har givet samtykke registreres dette direkte hos Steno og opbevares dér. Oplysning om deltagerens samtykke videregives til almen praksis via e-Boks. Når

praksis har modtaget besked, skal det tydeligt og umiddelbart fremgå af patientjournalen, at personen deltager i projektet "Digital årskontrol". Desuden anbefales det, at man for personer, der har givet samtykke, i deltagerlisten angiver den måned, hvor de skal til diabetes årskontrol, så man løbende — fx med månedlige intervaller — kan kontrollere, om årskontrollen er gennemført, og følge op ved eventuel manglende gennemførelse.

Både samtykke og afslag på deltagelse skal registreres på Deltagerlisten, så man kan følge op på potentielle deltagere, som ikke har besvaret henvendelse (non-respondere). Opfølgning og fornyet kontakt til non-respondere skal ske cirka to uger efter første opringning. Det er op til almen praksis, som kender den personen, om dette foregår telefonisk eller ved at sende en ny besked. Ved fortsat manglende reaktion efter yderligere to uger gives en 3. påmindelse. Som ved 2. forsøg er det op til praksis at afgøre formen for kontakten.

Ikke egnede, trods opfyldte kvantitative kriterier.

For personer, der opfyldte de parakliniske inklusionskriterier, men efterfølgende vurderes uegnede til digital årskontrol, skal den primære begrundelse for, at denne er vurderet uegnet, registreres i deltagerlisten. Disse oplysninger videregives til projektet i anonymiseret form via fortløbende nummerering uden brug af CPR-numre.

Opgaver efter rekruttering er afsluttet

Cirka 6 uger efter at potentielle deltagere er kontaktet, og der af en til to omgange er fulgt op på non-responders, afsluttes afkrydsningen af deltagerlisten. Således at der ud for alle CPR-numre er sat kryds i enten samtykke, uegnet eller non-responder. Derefter indsendes højre side af deltagerlisten (Opret kopi af dokumentet og slet venstre kolonne med CPR-numre eller scan dokumentet ind og tildæk venstre kolonne med cpr-numre). Dokumentet skal sendes til (indsæt mail adr.): Vi bruger informationen til at evaluere på antal personer, som har "takket nej", antal "non-respondere" og uegnede, samt årsager hertil.

I modtager nu skema, hvor der for hver deltager registreres seneste blodtryk, vægt og rygestatus, og skemaet skal derefter sendes til (indsæt mail -sikkerpost).

Den digitale årskontrol

Når deltageren har givet samtykke til deltagelse i forsøget, bliver den kommende diabetes årskontrol digital. Blod- og urinprøver tages som vanligt. Der skal anvendes webreq-pakken "digital årskontrol", da den indeholder den samlede pakke af blodprøver og skemaer til den digitale årskontrol. Deltageren skal selv måle blodtryk

hjemme og veje sig, hvis vedkommende har en badevægt. I tilfælde af at deltageren ikke har mulighed for at veje sig, kan vægtfeltet efterlades tomt, eller deltageren kan vejes i forbindelse med blodprøvetagningen. Blodtryksmålinger skal foretages med et apparat med armmanchet; håndleds-, finger- eller smartwatch-målinger accepteres ikke.

Deltageren skal hjemme besvare KRAM-spørgsmålene og et kort screeningsskema om symptomer på komplikationer og medicinudfordringer (bilag 6). Når alle prøvesvar foreligger, vurderes resultaterne i forhold til de individuelle mål i forløbsplanen og øvrige journaloplysninger, og der sendes svar i lægesystemets beskedmodul. Samtidig sikres, at der er recepter på relevant diabetesmedicin for det kommende år.

Der udarbejdes en standardfrase, som kan suppleres med fritekst. Frasen indeholder oplysninger om, at deltageren:

- Skal fortsætte sin medicin uændret, medmindre andet er oplyst, og at der er recepter til et års forbrug på apoteket;
- Kan se sine diabetesprøvesvar og mål i forløbsplanen i Min Læge-appen, på forloebplan.dk eller i sundhedsjournalen via sundhed.dk;
- Skal bestille tid til almindelig årskontrol med fysisk fremmøde om et år for at få svar.

Hvis der findes forhold, som kræver behandlingstiltag, er det op til den ansvarlige sundhedsperson at vurdere, om dette kan gøres over mail eller telefon eller kræver, at deltageren bestiller en tid.

Året efter at deltageren har haft sin digitale årskontrol, vil diabetes årskontrollen igen være en standard årskontrol med fysisk fremmøde til svar.

Generelt om blodprøver og intervaller for blodprøver

Der indgår kun én årlig planlagt HbA1c-kontrol i projektet. Hvis det findes medicinsk indiceret at kontrollere HbA1c imellem årskontrollerne, skal dette naturligvis gøres. Det påvirker ikke deltagelsen i projektet.

Personer med T2D og normal og stabil nyrefunktion skal jvf. Den nationale behandlingsvejledning for type 2-diabetes have minimum 1 årlig kontrol af nyrefunktionen. Det gælder også ved samtidig behandling med Metformin og ARB-blokade (ACE-inhibitor eller angiotensin-2 receptor antagonist). Med mindre særlige forhold gør sig gældende vil det hos ovennævnte gruppe således være tilstrækkeligt med én årlig kontrol af nyrefunktionen.

Blandt personer med T2D, som skal have kontrolleret nyrefunktionen flere gange årligt, vil der være nogle, som er vant til, at der samtidig kontrolleres HbA1c. Hvis dette bidrager til trykthed for deltager og/eller behandler, er det IKKE en hindring for at deltage i projektet.

Data fra almen praksis på deltagere

I december 2027 vil I modtage et auditskema, som indeholder alle tilmeldte deltagere fra jeres klinik. Der skal for hver deltager registreres blodtryk, vægt og rygestatus, som er registreret i forbindelse med deltagerens digitale årskontrol og skemaet skal derefter sendes til (indsæt mail -sikkerpost). Hvis deltagerens digitale årskontrol blev omgjort til en standard årskontrol skal dette markeres.

Samme skema vil I modtage kort efter projektets afslutning december 2028, hvor blodtryk, vægt og rygestatus, som er registreret i forbindelse med deres standard årskontrol, skal registreres.

Kontakt

Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os:

Kirsten Christensen,

Overlæge, speciallæge i almen medicin

KICHIS@rm.dk

Tlf. +45 2992 5648

Bilag

Bilag 1. Symptomscreeningsskema.

Bilag 3. Rekrutteringsbesked 1.

Bilag 4. Rekrutteringsbesked 2.

Bilag 5. Skriftlig deltagerinformation.

Bilag 2. Instruks for mundtlig deltagerinformation.

Bilag 6. Samtykkeerklæring